<2021 본 3 학년말고사-내과>

총 **60 문제** 중 **60 문제** 복원

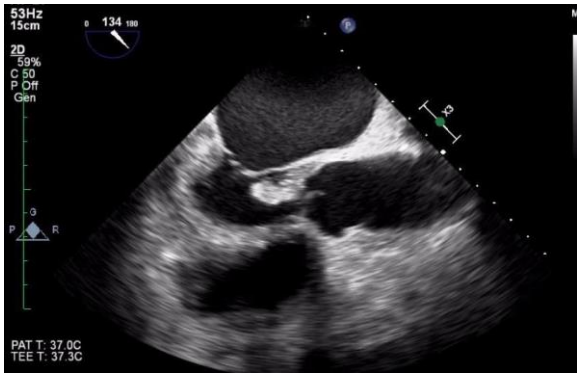
<심장내과>

총 **10 문제** 중 **10 문제** 복원

야마 거의 안타고 매우 어려웠습니다. 심초음파 소견 문제가 많이 나왔는데 해석하기 어려웠습니다. 당해 본 2 야마도 전혀 타지 않은듯..

1. 55 세 여성이 갑자기 (3 일전이었나,..) 발열과 숨 차는 증상으로 응급실에 내원하였다. 흉골 좌측에서 이완기 심음이 관찰되었고 몸에 부종이 관찰되었다. TEE 소견은 다음과 같고(동영상으로 주워졌고 도플러는 안줌, 참고로 AR), x-ray 소견은 다음과 같다 (LVH, Edema) 확인되었다. 치료법은?

   TnI 정상　　혈액 배양 결과: streptococcus

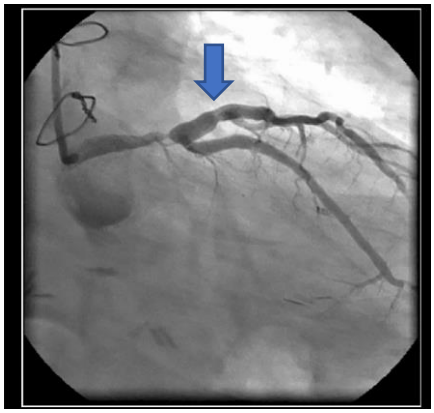


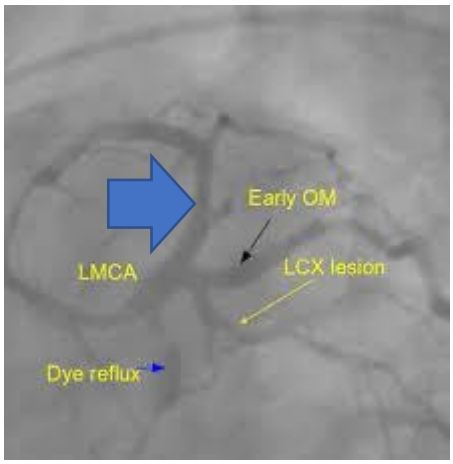
   - <u>수술적 대동맥 판막 치환술</u>
   - 경피적 대동맥 판막 치환술
   - 승모판 치환술
   - 항혈소판제
   - 항응고제

2. 89 세 환자 호흡곤란으로 내원. 계단을 오를 때 숨이 차서 힘들었다고 하며 최근에는 평지 걸을 때도 힘들었다고 함. 실신한 적도 있다고 함. 흉골 우측에서 수축기 심잡음 들림. 수술하기 싫다고 함. X-ray (LVH 있었음) ECG (A fib) 심초음파 동영상 주어짐 (도플러는 안줌, AS, 아마 TEE 주어진듯) 치료는?

   - 제세동기
   - Ablation
   - 승모판막 치환술
   - 수술적 대동맥 판막 치환술
   - <u>경피적 대동맥 판막 삽입술</u>

3. CAG - spider view 랑 다른 view 하나. 막힌 혈관(화살표 한 혈관)의 이름은? (막힌거는 Left main 이고 화살표는 LAD 라는 말이있습니다.)





   - LCX
   - <u>LAD</u>
   - RCA
   - Left main

4. 35 세 남성이 언덕을 올라갈 때마다 숨이 차서 내원. 심초음파에서 hCMP 소견 보였다(영상으

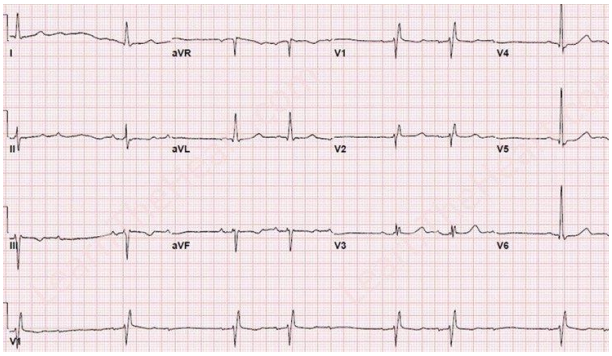
로 제시). 여러 조건 주고 그 중에서 급사 위험 인자 고르기.

LV thickness: 34mm, 그 외에 여러 개 줌,,

- 가족력
- LV thickness
- 고혈압
- 나이
- 숨참

가족력 선지는 가족력이라는 말만 주고 질환, 급사 없었음.

5. 다음 심전도는? (답 논란,, Irregular 하긴 했는데 중간중간 Pause 있었음



- Sinus pause
- 2 도 방실 차단
- Complete block
- Tachycardia bradycardia syndrome

6. 숨참 증상과 부종 등 심부전 있는 환자. EKG 는 a.fib 소견. 맥박은 117 정도였음. 이 때 생존률을 올리기 위해서 추가할 수 있는 약물은? (문제에 천식은 없었습니다.)

- Thiazide
- Furosemide
- Amiodarone
- Bisoprolol

7. 60 세 남성 1 시간 전부터 발생한 조이는 듯한 통증으로 내원하였고 가라앉지 않음. X-ray 에서 폐혈관들 잘 보임. 해야 될 처치? 검사소견: Troponin 증가

EKG: STEMI, 혈압 낮음

- 폐동맥 색전술
- 응급 경피적 관상동맥 중재술
- 경구 항응고제

8. 65 세 남성이 3 년 전부터 비허혈성 심부전으로 약을 CCB 와 이뇨제를 사용하고 있었다. 최근 2 주 전 감기에 걸린 이후로 숨차는 증상이 악화되었으며, 입원 후 ARNI + BB + (그외 기억 안나는 약) 약을 추가하여서 현재는 증상이 호전된 상태이다.

* 혈액검사 Na/K/Cl 정상, random plasma glucose 246mg/dL 당화혈색소 : 10.1% * 심장초음파 : EF 36%, LV wall dyskinesia

환자의 혈당을 조절하고, 심장 질환으로 인한 사망(cardiac event)을 감소시키기 위해 추가할 수 있는 약제는?

- SGLT-2 inhibitor
- 그 외 관련없는 선지

9. 어떤 환자가 쓰러져서 왔다. 심전도는 다음과 같았다. BP 90/60, HR 54 쇽과 심실빈맥이 계속되어 ECMO 를 받았다. 다음으로 응급으로 곧바로 시행해야 할 처치는? (답 논란)

심전도: STEMI 후 절묘하게 V fib 이 계속됨

II, III, aVF ST elevation

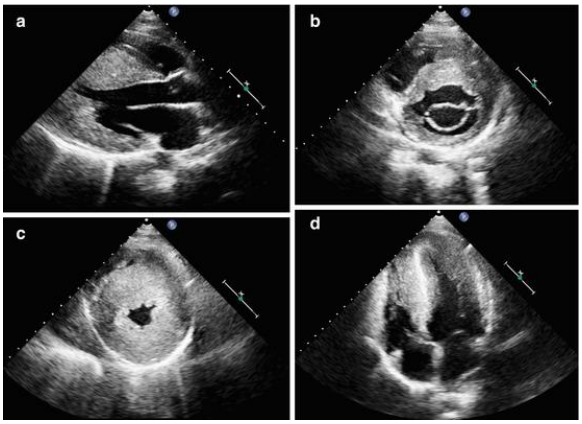
aVL ST depression

TnI: 0.020 인가로 정상

- Beta blocker
- ICD
- 일시적 심박동조율기
- 응급관상동맥 중재술

Inferior wall STEMI 후 V fib 온 환자로 ECMO 시행받았는데 HR 이 낮아서 temporary pacemaker 인지 PCI 인지 논란되는 문제. PCI 가 답일 것으로 생각되긴함.

10. 20 대 남성 축구하다가 심정지가 왔다고 함. 심폐소생술 후 심장 리듬 돌아온 상태로 EKG 찍었고 정상소견. 심초음파는 다음과 같다. (참고로 H-CMP) 해야할 처치는?



- 경피적 승모판 재건술
- 경피적 대동맥판 삽입술
- ICD 삽입

<호흡기내과>

총 **10 문제** 중 10 **문제** 복원

이전 학년말고사 기출문제에서 꽤 많이 출제되었습니다.

11. 결핵치료 후 실패한 환자 MTBDR*plus* 검사 결과 rpoB_D516V mutation (Rifampicin resistance) katG_S315T mutation (Isoniazid resistance) 로 나왔다. 다음 항생제 선택 시 내성 결과가 중요한 항생제는?

- amikacin
- levofloxacin
- pyrazinamide
- cycloserine
- Linezolid

12. 26 세 여자가 열, 기침을 주소로 내원하였다. 병원에서 측정한 체온은 38.5℃ 였다. 환자에게 적절한 치료는?



- 항생제
- 항암제
- 해열제
- 진해제
- 흡입 스테로이드

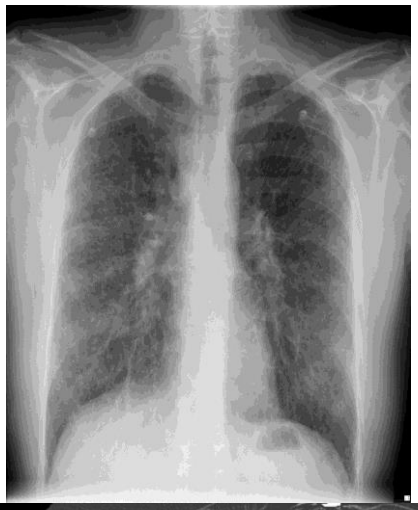
13. 호흡기 증상으로 입원한 환자, 검사로 SARS-CoV2 양성 진단받아 음압병동에서 치료받고 있음. SpO2 89%. 적절한 치료는? (CT 사진도 있었음)

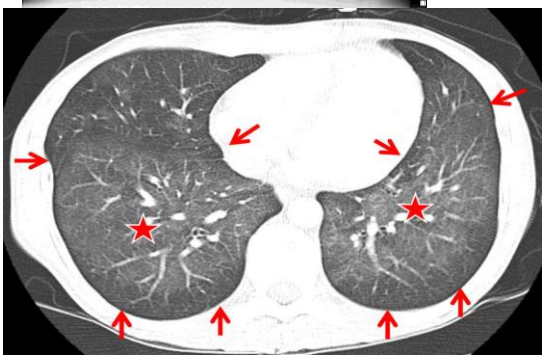
- Remdesivir

- Regdanvimab
- Levofloxacin
- 나머지 처음 보는 약제

*Remdesivir, Regdanvimab 모두 치료제이지만, Regdanvimab 의 적응증이 SpO2 94% 이상이라 답이 Remdesivir

14. 감기, 기침, 발열 모두 없는 40 세 여자, X-ray 상 이상소견 보여 기관지 흡인, 세균배양, 진균배양, 결핵검사했으나 모두 검출되지 않음. CT 소견은 비슷한 거 주워왔습니다(CECT Lung window: 양측 폐 다발성 소결절, Mediastinal window: 이상 소견 없음,종격동 커지지 않음). 진단을 위해 시행할 검사는?





- Immunoglobulin Release Test
- Xpert TB test
- 기관지내시경 초음파
- <u>경피적 폐 생검</u>
- ACE 검사

*CT 상 종격동 비대 없었고, Peripheral Lung 도 침범되지 않은 Galaxy sign 처럼 보였습니다.

종격동 림프절이 bilateral 하게 커져서 sarcoidosis 를 의심해야한다는 의견이있었습니다. (이런경우 EBUS 가 답)

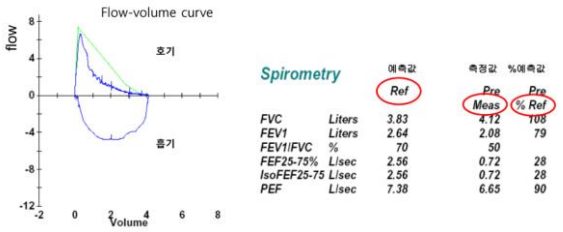
15. (야마) 60 대 남성이 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 다음은 CT, PET-CT 검사 결과이다.(carina 주변에서 hypermetabolic 한 LN 3 군데 보임) 그리고 시행한 검사에서 사용한 기구와 채취한 검체의 육안적 소견 사진을 보았을 때, 이 검사의 이름은?





- Autofluoroscence Bronchoscopy(AFB)
- Electromagnetic Navigational Bronchoscopy (ENB)
- <u>Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration (EBUS-TBNA)</u>
- Transbronchial Lung Biopsy (TBLB)

16. (야마) 61 세 남성 3 개월 전부터 시작된 호흡곤란을 주소로 내원. PFT 검사 결과 상 진단은?
(강의록에서 발췌함. 시험은 실제 사진)

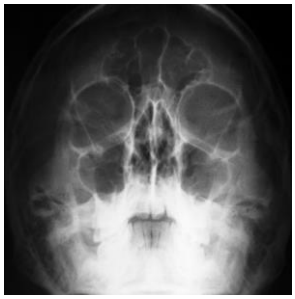


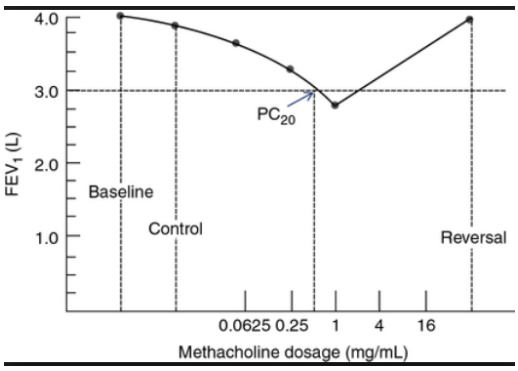
- <u>COPD</u>
- IPF

- Pneumonia
- Pneumothorax

17. (야마) 28 세 여성 2 개월 전 시작된 기침을 주소로 내원, 다음은 CXR 과 부비동 x-ray 검사소견이다. 메타콜린 기관지 유발 검사 8mg/mL. 시작치료로 가장 적절한 것은?







- LABA
- Inhaled corticosteroids
- Leukotriene modulator
- Anticholinergic agent
- Anitihistamines

18. (야마)34 세 남성이 2 년 전 결핵을 진단받고 3 개월 간 약제를 복용하다가 증상이 호전되어 자의로 복용을 중단하였다. 2 개월 전 기침이 있어 다시 병원에서 결핵을 진단받고 HREZ 치료를 받고 있는 중이다. 경과를 보기 시행한 검사 상 AFB (+), CXR 에서 우측 상부에 atelectasis 및 opaque lesion 더 심해진 소견이 관찰되었다. 다음 중 옳은 보기를 고른 것은?

가) Xpert MTB/RIF 검사를 한다.

나) 초치료 실패에 해당한다.

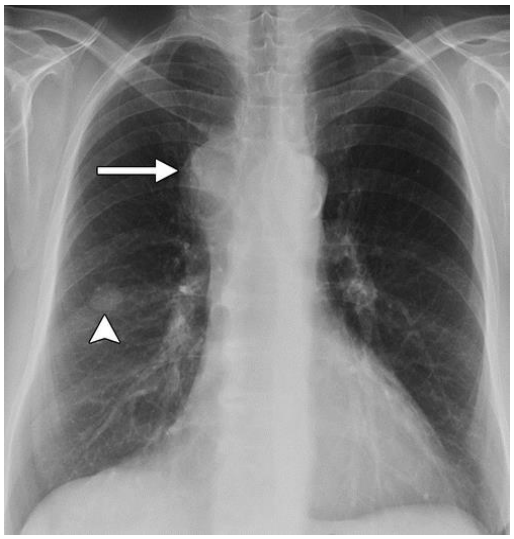
다) 약물을 잘 복용하고 있는지 확인한다.

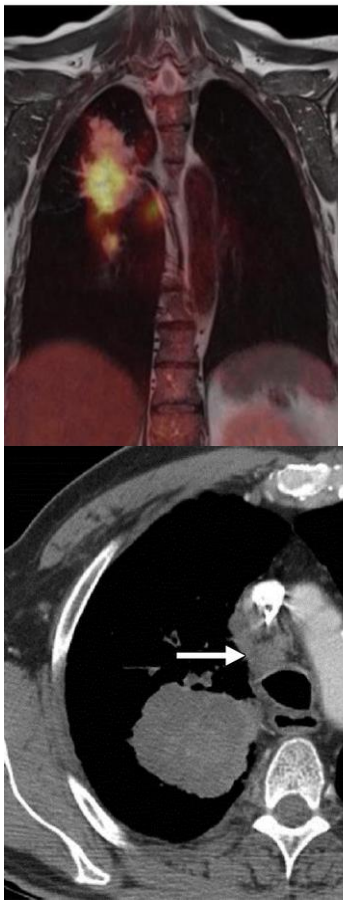
라) Paradoxical response 일 수 있으므로 현재 치료를 유지한다

- 가, 나, 다
- 가, 다
- 나, 라
- 가, 나, 다, 라
- 라

답논란. 순서는 맞게 복기함. 결핵 초치료의 정의는 4 개월 치료 후 실패이기 때문에 '나'선지가 틀렸다는 의견도 있었음. CXR 소견은 주어지지 않았다는 의견도 있음.

19. (변형야마) 얼굴이 붓고 두통 있으며 호흡곤란 동반되어 찍은 Chest PA 에서 이상소견 보여 시행한 CT, PET-CT 소견이다. Brain MRI, Bone scan 상 이상 소견 없었음. 필요한 치료는? (없는 사진이라서 소세포암에 맞는 사진 긁어왔습니다. 병기설정에는 하단 설명 참고해 푸시면 됩니다.)





- 근치적 항암치료
- 복합항암방사선 치료
- 수술
- 경과관찰
- 고식적 항암치료

*PET-CT 그림이 Coronal 한 장, 간과 위까지 나왔는데 [Main mass, Ipsilateral Mediastinum, Subcarinal LN] 말고는 Hot uptake 없었습니다.

20. (야마) COPD 의심 환자. 중증도 평가를 위해 확인해야 할 것은?

- 호흡곤란 증상 설문지
- 폐확산능
- 6 분 걷기 테스트
- 동반질환

<소화기내과>

총 **10 문제** 중 **10 문제** 복원

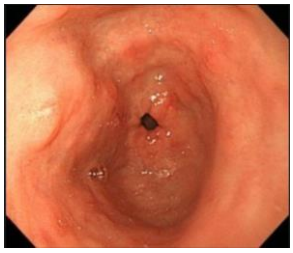
21. 20대 여자, 이틀 전부터 발생한 혈변 주소로 내원. 대장 내시경 결과 직장부터 근위부 맹장까지 연속적인 병변 사진(이라고 문제에 적혀있었으나 출제 실수로 사진 안 주어짐. 그래서 전원정답처리) 진단은?

- 거짓막대장염
- 궤양성대장염
- 크론병
- 직장암
- 게실 출혈

22. 50대 남성 토혈을 주소로 내원. 관절염으로 평소 NSAID 복용 중. 압통 및 반발 압통 있음. 가장 먼저 시도해보아야 할 검사는?

- 식도내압검사
- 복부초음파
- 복부ct
- 위내시경
- 대장내시경

23. (위 내시경 검사 상 미란성 위염 주어진 사진. 비슷한 사진으로 첨부). 가장 적절한 치료는?



- 양성자 펌프 억제제
- H2 blocker
- 항생제

24. 27세 남성 2시간 전부터 발생한 혈변을 주소로 내원. 혈변 두차례 하여 총 500ml이고 혈압 76/42 → 교정 후 100/80 됨. 다음으로 시행하여야 할 검사는?

    - 상부위장관내시경
    - 대장내시경

25. 71세 남자. 혈변을 주소로 내원함. 좌하복부 통증 호소하였고 좌하복부 압통은 약하게 있었지만 반발 압통은 없었음. 만져지는 종괴는 없었음. 고혈압과 당뇨 15년 전부터 있어서 약 복용중. 혈압 140/90. 진단은? (답논란)

    - 게실출혈
    - 허혈성 장염
    - 구불결장암
    - 궤양성 대장염

26. 47세 여성. 건강검진에서 의심되어 1년전 검사 받고 이후 올해 검사 못 받았다고 한다. 그래서 이와 관련된 검사 원해 내원하였고 과거 검진 기록은 다음과 같았다. 향후 계획은?

    HB Ag (-) HBs Ab (+) HCV Ab(+) 나머지는 정상(진짜 이렇게 최소한의 정보만 적힘)

    - 경과관찰
    - HCV RNA PCR을 확인한다.
    - 경구 항바이러스제
    - 인터페론

27. 50세 여성. 10년 전 B형간염 진단받았다. 6개월 전부터 복수 심해졌고 이뇨제로 조절 안돼서 복수 천자 2주마다 한번씩 시행하였다. 3개월 전 간성 뇌증 심해져서 Child C 간성뇌증 진단받음. 향후 가장 알맞은 치료 방향은?

    - 간이식
    - 경구 항바이러스제 변경
    - TACE
    - 인터페론 & 리바비린

28. 40대 남성. HCV의심된다고 내원하였다. 치료법은?

    HCV RNA 58,000IU/mL, HCV AB (+)

    HBV, HAV IgG (+), 나머지 (-)

    AST 150, ALT 130

    다른 검사는 정상 (엄청 길게 많은 정보 적혀 있었음)

    - Direct acting agent(경구 항바이러스제)
    - 스테로이드
    - Sorafenib
    - Tenofovir
    - Entecavir

29. 30대 남성. 167cm/75kg. 1일전 복통 생겨서 내원하였다. 영상 소견과 검사 수치가 다음과 같을 때 원인은?

    영상: nonCE, 강조된 부분 x

    Vital sign 110/80-86-20-38.1

    Amylase 650 Lipase 750

    CRP 40 ESR 30

    중성지방 15,800mg/dL, Cholesterol 440mg/dL

    - 감염
    - 약물
    - 담석
    - 고중성지방혈증

30. 60대 여성. 우상복부 통증과 발열로 내원하였다. 6개월 전에 담낭절제술 받았다. 검사 시행 결과 아래와 같았다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?





(화살표 없었음.) ERCP: 총담관 내 담석

- 응급 수술로 Endoscopic sphincterotomy & basket stone extraction를 시행한다.
- 담낭절제 과거력과는 관련 없다
- 담관 내에 생기면 콜레스테롤 담석이다
- 경과 관찰하면 된다.
- 수액 & 항생제로 치료하면 된다.

<신장내과>

총 **10 문제** 중 **10 문제** 복원

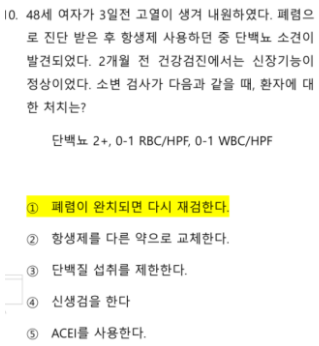
당해 계통에서 탐. 학기말 고사 기출에서는 전혀 타지 않음

31. 48 세 여자가 폐렴으로 진단 후 항생제 사용하던 중 단백뇨 소견이 발견되었다. 2 개월 전 건강검진에서 신장기능은 정상이었다. 소변 검사가 다음과 같을 때 환자에 대한 처치는?

Scr 1.09

소변 검사: Up/UCr 0.4, SG 1.03 …

- 폐렴이 완치되면 다시 검사한다
- 항생제를 교체하여 치료한다
- 신장생검을 한다


10. 48세 여자가 3일전 고열이 생겨 내원하였다. 폐렴으로 진단 받은 후 항생제 사용하던 중 단백뇨 소견이 발견되었다. 2개월 전 건강검진에서는 신장기능이 정상이었다. 소변 검사가 다음과 같을 때, 환자에 대한 처치는?

단백뇨 2+, 0-1 RBC/HPF, 0-1 WBC/HPF

① 폐렴이 완치되면 다시 재검한다.
② 항생제를 다른 약으로 교체한다.
③ 단백질 섭취를 제한한다.
④ 신생검을 한다
⑤ ACEI를 사용한다.

(2021 당해 야마)

32. 50 세 남자로 몸이 부어 내원하였다. 체중증가 10kg 였으며 호흡곤란은 호소하지 않았다 혈압은 정상범위. 부종의 기전은?

소변 검사: PCR 4,239, RBC 0-1/HPF, WBC 0-1/HPF

- 정맥 정수압 증가
- 혈액 내 삼투압 감소
- 모세혈관 투과성 증가
- 간질 삼투압 증가
- 혈액 내 정수압 감소

33. 육안혈뇨 있는 사람 160/100 고혈압에 혈압 높게 측정되고 당뇨 있으나 잘 조절 됨. 망막병증 없음. 단백뇨 있음. 24 시간 단백 0.5g 혈뇨 4+

CT 로 한쪽 renal artery perfusion 안되는 사진 주어짐. 혈뇨 원인은?

- 당뇨콩팥병
- 신결석
- 방광암
- 급성콩팥토리염

고혈압으로 인한 Glomerulonephritis 로 의심됨

34. 부종으로 내원. 검사결과 단백뇨 2+, 함요부종, 단백뇨 치료를 위해 이 환자에게 해야하는 것은?



- 나트륨 섭취 제한
- 고단백질 식이
- ACEi
- HMG-CoA reductase

35. ALS 있고 호흡곤란 온 환자. 수분 저류 해결하기 위해 가장 적절한 치료는?

혈압: 80/30

혈액검사: 백혈구 상승, 혈소판 감소, BUN/Cr 98/6.9

소변검사: albumin 2+, WBC 5-10/HPF, RBC many/HPF

Chest xray 상 pulmonary edema

- Continuous venovenous hemodiafiltration (CRRT)
- CAPD
- Intermittent hemodialysis
- Online hemofiltration
- Automated peritoneal dialysis

36. 70 세 남성 4 일전에 감기 때문에 알레르기 약을 복용하였음. 그 후에 소변이 나오지 않아서 내원함. 소변양은 거의 적었음.

(이런식으로 방광 꽉차있는 느낌의 ct)



- 도뇨관 삽입
- 방광 창냄술
- 이뇨제
- 수액 요법

37. 중년 여성 당뇨병 병력. 최근 호흡곤란 심해지고 심비대 보임. 심장 EF 저하된 소견. 신장 GFR 는 45 정도, BUN/CR 수치 안좋았음. Urine ACR 500 정도 였음. 이 환자에게 사용할수 있는 약?

- SGLT-2 Inhibitor
- Metformin
- Sulfonylurea
- DPP-IV antagonist

* 경구 혈당강하제 중 SGLT-2i 와 GLP-1RA 가 심혈관계 동반질환을 가진 환자에서 추천됨. 보기에는 GLP-1RA 가 없었음. 심장내과에서도 유사한 문제 1 문제 출제됨. 밑에 문제와 비슷한 문제이나 선지에 GLP-1RA 없었음.

15. 62세 남성이 당뇨병의 병력이 있다. 최근 호흡곤란이 심해져서 내원하여 신장내과로 협진을 의뢰받았다. eGFR=45, BUN/Cr (?), 혈당 8.3% 이었고, X-ray에서 심비대가 뚜렷하게 관찰되었고, EF=43%이었다. 이 환자에게 사용할 수 있는 당뇨병 약으로 옳은 것은?

① Glucagon Like Peptide-1 receptor agonist
② Dipeptidyl peptidase 4 inhibitor
③ Sulfonylurea
④ Metformin
⑤ Alpha-glucosidase inhibitor

*해설 : GLP-1A는 심부전 및 AS-CVD 위험이 큰 환자에게서 1차적으로 고려되는 약제이고, eGFR이 매우 낮아지지 않는 이상 사용 가능합니다. (강의록 기준)

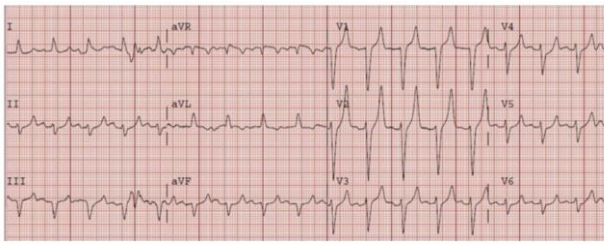
고혈압, 당뇨 있는 환자 Urine ACR 500 정도, GFR 감소되어있었음. 신초음파 2 개. 크기 각각 10, 9.8 cm



원인은?

- 만성신부전
- Acute glomerulonephritis
- Acute tubulointerstitial disease

38. 무증상 20 세 환자가 혈액검사결과 소견을 주소로 내원하였다. K:7.7 이었고, ECG 는 tall T wave EKG. 다음으로 해야 할 것은? (논란)



- Ca gluconate
- 투석
- 혈액검사 재검

심전도에 Tall T 없어서, 혈액검사 이상으로 재검해야 된다는 의견이 있었음. 심전도를 자세히 봐야할듯

39. 38 세 한약복용한 환자가 야뇨증과 하지문제 동반으로 내원하였다. 가장 적절한 원인은?

혈압: 180/100

혈중 Na-K-Cl 140-2.5-101

소변 Na-K-Cl 60-50-40

- Cortisol
- Vasopressin
- Aldosterone
- Angiotensin II
- Catecholamine

20 야마 문제와 동일

22. 38 세 한약복용한 환자가 야뇨증과 하지문제 동반으로 내원하였다. 가장 적절한 원인은? (Renin, aldosterone, cortisol 수치 없었음)

혈압 180/100

혈중 Na-K-Cl 140-2.5-101

소변 Na-K-Cl 60-50-40

- cortisol
- vasopressin
- aldosterone
- angiotensin II
- catecholamine

<내분비내과>

총 **5 문제** 중 **5 문제** 복원

* 서울 3 문항, 구리 2 문항 출제

* 서울 내분비내과는 시험 전 주에 출제 범위 공지 (pf. 박정환) : 부신, 골다공증, 부갑상선

40. 35 세 여자가 2 개월 전부터 목 앞쪽이 붓는 것 같아 병원에 왔다. 목의 앞면이 전반적으로 부어 있었으며, 압통은 없었다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은? (답논란)

* 혈액검사
Free T4 0.6 (참고치 0.8~1.7)
TSH 12.6 (참고치 0.34~4.25)
anti-TPO antibody (+)
* 갑상선 스캔 : 섭취 감소

- 산후 갑상선염
- 그레이브스씨병
- 아급성 갑상선염
- 무통성 갑상선염
- 하시모토 갑상선염

* 산후 갑상선염도 위와 유사한 검사결과를 나타낼 수 있으나, 출산력이 제시되지 않았으며 무증상 갑상선기능저하와 경부의 미만성 종대가 하시모토 갑상선염의 특징적 소견에 해당되어 위와 같이 체크함. 하지만 RAI 감소가 산후 갑상선염의 특징이고 하시모토에서는 RAI 가 다양하게 나타나므로 산후 갑상선염의 가능성을 배제 불가능하고, 산후 갑상선염이 답일 가능성도 높아서 둘 다 체크해놓음.

41. 20 대 남자가 다뇨, 다갈, 다음을 주소로 내원하였고 1 일 소변이 4L 였다. 검사해야 하는 것은?

- 요 오스몰
- 요 나트륨
- 요 Cr

DI 감별

42. 45 세 남자가 건강검진에서 촬영한 CT 소견 상 부신의 종물이 관찰된다며 병원에 왔다. 2 년 전부터 고혈압 약을 복용하고 있었으나, 혈압이 잘 조절되지 않는다고 한다. 이 환자에게 시행할 수 있는 검사는? (답논란)

- 0.9% saline loading test
- Captopril stress test
- Clonidine suppression test
- Spironolactone stress test
- Low dexamethasone suppression test

* 부신우연종 환자로, cushing syndrome, primary aldosteronism 이나 pheochromocytoma 등이 고혈압의 원인일 수 있음. 제시된 검사들 중 유의미한 검사는 saline loading test 임. 하지만 Low dexa suppression test 가 답이 될 수도 있음.

43. 55 세 여자가 건강검진에서 혈중 칼슘 농도가 높다는 이야기를 들었다며 병원에 왔다. 검사결과는 다음과 같다. 조치는?

* 혈액검사
Ca 10.6 (참고치 9.6-10.2)
Cr 0.8 (참고치 0.6-1.2)
이외 모든 혈액검사 항목 정상
* 골밀도 검사 : L1~L4 T-score -0.9, Femur neck T-score -0.7

- 추적관찰
- 부갑상선절제술
- 비스포스포네이트 복용
- 이뇨제 복용
- 생리식염수 정맥주사

* 무증상 고칼슘혈증의 수술적 치료 적응증 4 가지 중 어느 것에도 해당하지 않으므로, 추적관찰하는 것으로 충분함.

44. 59 세 남자가 골밀도 검사를 위해 병원에 왔다. 시행한 골밀도 검사(DXA) 소견은 다음과 같다. 적절한 해석과 진단이 바르게 연결된 것은?

Region	T-score	Z-score
L1	-3.3	-2.8
L2	-2.4	-2.6
L3	-1.8	-2.5
L4	-1.4	-2.0
L1~L4	-2.2	-2.2
Femur neck	-2.1	-1.6
Feumur total	-1.9	-1.5

- Z-score -2.8, 골다공증
- Z-score -1.5, 정상
- Z-score -1.6, 골감소증
- T-score -2.2, 골감소증
- T-score -3.3, 골다공증

* 50 세 이상의 남자이므로 T-score 를 적용함. L1~L4 의 평균값, fumur neck, total proximal femur 의 T-score 중 가장 낮은 값을 기준으로 판정함.

<혈액종양내과>

총 **5 문제** 중 **5 문제** 복원

45. Corrected reticulocyte count 를 계산하여라 (주관식) (Hb 안줌)

    Hct 18, Reticulocyte 1.5%

    정답: 0.6

46. 위절제술 받은 환자가 어지럽고 숨차는 증상으로 내원. Lab 은 다음과 같다. 치료는

    Hb9.0 MCV 72(기준치 이하)

    Ferritin 13

    - 경구 철분제
    - EPO
    - 엽산

47. (같지는 않지만 대충 이런 케이스) 43 세 남자가 3 주간 지속된 열감과 잇몸 출혈로 병원에 왔다. 평소에는 건강하였고, 1 년 전 건강검진에서는 별 이 상이 없었다. 최근 1 개월 사이에 체중이 5 kg 정도 감소하 고, 밤에 식은땀이 많이 나서 베개가 젖는다고 한다. 혈압 125/82 mmHg, 맥박수 76/분, 호흡수 18/분, 체온 37.1℃ 이다. 결막이 창백하였고, 입 안 점막에 점상 출혈이 관찰 된다. 간과 비장은 만져지지 않는다. 혈액검사와 골수천자 생검 검사 결과이다. 환자에서 변이가 나타났을 때 사용 가능한 표적 치료는?

    백혈구: 22,900/mm3 [4,000-10,000/mm3] 혈색소: 7.7 g/dL [13-17 g/dL] 혈소판: 37,000/mm3 [150,000-450,000/mm3) 분절 호중구: 3% [50-75%] 림프구: 17% [22-44%] 단핵구: 5% [2-9%] 호산구: 2% [1-5%] 호염기구: 1% [0-2%] 늦골수세포: 5% 골수세포: 12% 전골수세포: 7% 골수모세포: 48% 골수 천자 생검 검사 - 골수세포질: 90% 이상 - 골수모세포: 80% - 면역표현형검사: CD3 음성, CD7 음성, CD13 양성, CD19 음성, CD34 양성, Myeloperoxidase 양성, TdT 음성

    - FLT3 internal tandem duplication mutation
    - NMP1 mutation
    - RUNX1 mutation
    - TET1 mutation
    - CBFb mutation

48. 어떤 환자가 어지러움이 심해져 내원하였다. 평소 두통과 어지러움이 있었다. 담배는 하지 않는다고 하였다. 왼쪽 갈비 밑으로 지라가 만져졌다. 검사결과가 다음과 같을 때 해야할 검사는?

    Hb 18.6 WBC 17000 PLT 680000

    말초 혈액 도말에서 RBC, WBC, PLT 모두 증가

    - 트롬보포이에틴
    - 적혈구생성인자
    - 베타 2 마이크로 글로불린
    - 페리틴
    - 단백질 전기영동검사

49. Multiple myeloma 소견, lab 엄청 길게 줌 Intenational staging system 의 stage 는?

대표적 Lab) Albumin 3.4, M protein 5.5 b2 microglobulin 5.2

- 0
- I
- II
- III
- IV

<감염내과>

총 **5 문제** 중 **5 문제** 복원

50. 발열로 내원한 환자에게 감염성 질환을 의심할 때 물어봐야 할 질문이 아닌 것은?

- 직업
- 거주지
- 흡연, 음주력
- 최근 여행력
- 주변 사람들 중 비슷한 증상을 호소하는 사람이 있는지

감염 CPX 확인 항목 참고

51. 환자에게 바늘로 찔렸을 때 곧바로 우선 확인해야 하는 것은?

- 나의 HIV Ab
- 환자의 HBsAb
- 환자의 CRP
- 환자의 HCV Ab
- 나의 HAV Ab

배현주 P 피셜

52. (비슷한 사진 가운+마스크+장갑) 다음과 같이 주의해야 하는 경우는?



- 활동성 결핵
- 인플루엔자
- 신우신염
- CRE

53. 항생제 bioavailability 가 좋지 않아 경구로 섭취했을 때 전신으로 도달할 것이라 기대되지 않는 약물은?

- Metronidazole
- Amikacin
- Trimethoprim-Sulfamethoxazole
- Linezolid
- Ciprofloxacin

54. 심장 청진에서 잡음이 들리고 blood culture 에서 MSSA 나왔다. 이 때 나타날 수 있는 증상은? (첫번째는 완전 똑같은 사진, 나머지는 유사한 다른 사진이고 5 번째 사진은 저거와 거의 유사) (답은 1 번)

- 
- 

- 
- 
- 

<류마티스 내과>

총 **5 문제** 중 **5 문제** 복원

55. 30 대 남성. 무릎이 아프다며 내원. 평소에 구강 궤양이 있었는데 그 빈도가 잦아짐. 무릎 관절통도 있었음. 어머니가 류마티스 관절염으로 진단받았다고 함. 진단을 위해 필요한 검사?

    - Pathergy test
    - 무릎 X ray
    - 관절액 천자
    - CRP.

구강궤양 말고 무릎관절통에 집중하여 무릎 X-ray 를 촬영해야 한다는 의견도 있음.

56. 대칭적으로 손목, MCP joint 등을 침범한 전형적인 RA 환자. 현재 증상이 조절 안되는 심한 상태였음. 치료로 맞는 것은?

    - MTX 를 사용하게 된다면 folic acid 를 같이 줘야한다.
    - MTX 를 바로 시작하고, 하루에 한번 먹는다.
    - Steroid 는 질병을 조절하는 효과가 없다
    - 증상완화를 위해 NSAID 를 준다
    - 증상이 심해서 바로 biological DMARDs 로 시작한다

1 아니면 5 가 답으로 예상됨. MTX 사용 시 Folate 같이 줘야하고, MTX 는 일주일에 한번쓰는 약. 초기에 Steroid 써볼 수 있고, 성윤철 P 강의록 보면 NSAIDs 는 없다. 5 선지는 모르겠으나 MTX 가 첫번째로 사용해야 할 약임. 1 이 더 유력한 답으로 생각됨.

57. 50 대 여자가 2 개월 전부터 점점 심해지는 양쪽 손가락, 손목의 통증으로 내원하였다. 관절통은 6 년 전부터 시작되었고, 아침에 심하고 오후에 호전되는 양상이었다. 양 손목 관절에 부종과 압통, 오른쪽 팔꿈치에 부종, 오른쪽 세번째와 왼쪽 두번째 MCP joint 에 압통 있었다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. (혈액검사 결과 ESR, CRP 증가되어 있었고, ANA(-) 이었습니다.) 진단은?

    - 류마티스 관절염
    - 섬유근통 증후군
    - 성인형 스틸병
    - 반응성 관절염
    - 통풍

58. 50 대 남자가 3 일 전 갑자기 시작된 오른쪽 엄지 발가락의 관절통 때문에 내원하였다. 오른쪽 엄지 발가락이 붓고 압통 있었다. 외상은 없었다. 2 개월 전에도 오른쪽 엄지 발가락의 압통 있었으나 5 일 내 호전되었다. 이 환자에서 진단을 위해 가장 필요한 검사는?

- 관절액 편광현미경
- CRP
- 류마티스인자 (Rhematoid factor)
- 요산 (uric acid)
- 항 CCP 항체 (ACPA)

59. 20 대 남자. 무릎 통증 및 부종 아침에 심하고 오후에는 완화되었다. 허리 통증도 아침에 심하고 저녁에 완화되었다. 이 환자의 질병활성도 평가로 가장 적절한 것은?

- ESR 또는 CRP
- 요추 MRI
- 피로도
- 천정관절 MRI

AS 질병 활성도 평가 ASDAS: ESR/CRP+total back pain+pain,swelling, morning swiffness, patient global